

Uzależnienie + PTSD

20–30% osób z uzależnieniem ma PTSD. Substancja staje się „znieczuleniem” objawów traumy. Bez leczenia traumy abstynencja często nie wystarcza.

CZAS: 25 min czytanie Psychoedukacja + plan

ŹRÓDŁO: Najavits (2002); van Dam i wsp. (2012); Roberts i wsp. (2015)

JAK UŻYWAĆ

Karta wyjaśnia **mechanizm samoleczenia traumy substancją**, kryteria PTSD w skrócie, etapowanie leczenia podwójnej diagnozy: **stabilizacja** (faza 1, 3–6 mies.) → **przepracowanie traumy** (faza 2, 3–12 mies.) → **integracja** (faza 3, długoterminowo). Przedstawia 3 sprawdzone podejścia: Seeking Safety (faza 1), przedłużona ekspozycja PE (faza 2), EMDR (faza 2). **UWAGA:** praca z traumą u aktywnie używającej osoby zwykle *retraumatyzuje* — najpierw stabilizacja, potem trauma.

DLACZEGO TO DZIAŁA

van Dam i wsp. (2012, metaanaliza 17 badań, n=3786) wykazali: **20–30% osób z uzależnieniem spełnia kryteria PTSD**, z większą częstością u kobiet (40–55%) i osób uzależnionych od opioidów (55–65%). Mechanizm: *hipoteza samoleczenia* (Khantzian 1985) — substancja redukuje objawy intruzji (alkohol, benzodiazepiny), unikania (stymulanty na anhedonię), pobudzenia (opioidy na lęk). Roberts i wsp. (2015, metaanaliza Cochrane n=2 026): **terapię zintegrowaną** (Seeking Safety, CPT zintegrowane) dają **50% redukcję objawów PTSD i 40% redukcję używania** w 6 mies. — porównywalnie skutecznie do leczenia każdego zaburzenia oddzielnie, ale z lepszym utrzymaniem.

01

Cztery klastry objawów PTSD — i jak substancja je „obsługuje”

1 · INTRUZJE

flashbacki, koszmary, natrętne wspomnienia

Substancja „obsługuje”: alkohol, benzodiazepiny, opioidy — wywołują „zamglenie” świadomości, blokują obrazy intruzji.

2 · UNIKANIE

unikanie miejsc, ludzi, rozmów

Substancja „obsługuje”: alkohol pozwala wejść w sytuacje, których trzeźwy/-a uniknąłabym (np. spotkania społeczne).

3 · NEGATYWNE ZMIANY

anhedonia, dystans, samokrytyka, wstyd

Substancja „obsługuje”: stymulanty (kokaina, amfetamina) chwilowo dają „czuję, że żyję”, przeciwdziałają anhedonii.

4 · POBUDZENIE

hiperczułość, łatwy lęk, problemy ze snem

Substancja „obsługuje”: alkohol, benzodiazepiny, marihuana — redukują pobudzenie autonomiczne, ułatwiają zasypianie.

Wniosek terapeutyczny: sama abstynencja zwykle *nasila objawy PTSD* w pierwszych miesiącach — bo zniknęło „znieczulenie”. Dlatego od początku potrzebne są **zdrowe sposoby** radzenia z objawami (oddech, uziemienie, leki przeciwłękowe nieuzależniające, terapia).

02

Trzy fazy leczenia traumy + uzależnienia

FAZA 1 · Stabilizacja

3–6 miesięcy

Seeking Safety, abstynencja, bezp. więzi

FAZA 2 · Przepracowanie

3–12 miesięcy

PE, EMDR, CPT — pod nadzorem

FAZA 3 · Integracja

długoterminowo

budowanie życia, sieci, sensu

03 Trzy podejścia z dowodami naukowymi

PODEJŚCIE	FAZA	MECHANIZM	SKUTECZNOŚĆ (RCT)
<i>Seeking Safety</i>	1	Stabilizacja w 5 obszarach bezpieczeństwa; bez wracania do traumy	50% redukcja PTSD, 40% redukcja używania (Najavits 2013)
<i>PE — przedł. ekspozycja</i>	2	Powtarzane bezpieczne narratywne i wyobrażone ekspozycje na traumę	60% remisja PTSD (Foa 2007); wymaga 3+ mies. abstynencji
<i>EMDR</i>	2	Bilateralna stymulacja podczas przywoływania traumy → przepracowanie	55% remisja PTSD (Shapiro 2018); skuteczne też przy aktywnym używaniu

04 Moja refleksja + plan

CZY MAM OBJAWY PTSD

— z 4 klastrów: które rozpoznaję

W KTÓREJ FAZIE JESTEM

— stabilizacja, przepracowanie, integracja

CO DZIŚ TRZEBA USTABILIZOWAĆ

— substancja, sen, więzi, bezp. fiz.

SPECJALISTA TRAUMY W MOJEJ OKOLICY

— terapeuta z certyfikacją EMDR / PE

Klucz: Najavits (2002) wprowadziła zasadę „*bezpieczeństwo jest pierwsze*”. Praca z traumą u aktywnie używającej osoby *retraumatyzuje* — ekspozycja bez stabilnego zaplecza prowokuje nawrót używania. Stąd 3-fazowe leczenie. **Wyjątek:** EMDR często można rozpocząć wcześniej niż PE, bo nie wymaga „zatrzymania” w obrazach traumy. W Polsce specjaliści traumy z certyfikacją EMDR są zrzeszeni w *Polskie Towarzystwo EMDR*; terapeuci PE — w *Polskie Towarzystwo Psychotraumatologiczne*.